

Énfasis en Trastorno Límite, Antisocial y Evitativo

1. Introducción y relevancia clínica

Los **trastornos límite, antisocial y evitativo** representan tres de los **trastornos de personalidad más relevantes en la práctica clínica**, tanto por su frecuencia como por sus implicancias terapéuticas y sociales.

Cada uno ejemplifica un **modo disfuncional distinto de relacionarse con los demás y consigo mismo**, que genera sufrimiento significativo o daño a terceros.

- El **Trastorno Límite de la Personalidad (TLP)** destaca por la **inestabilidad emocional, impulsividad y riesgo suicida**.
- El **Trastorno Antisocial de la Personalidad (TAP)** se caracteriza por la **conducta delictiva, ausencia de empatía y desprecio por normas sociales**.
- El **Trastorno Evitativo de la Personalidad (TEP)** se manifiesta como **inhibición social extrema, miedo al rechazo y deseo frustrado de afecto**.

□ En el **EUNACOM**, estos tres trastornos son **preguntas clásicas**:

- TLP por su alta prevalencia y riesgo suicida.
- TAP por su diagnóstico diferencial con adicciones y conductas criminales.
- TEP por su frecuente confusión con fobia social o ansiedad generalizada.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Bases biológicas comunes

Aunque difieren clínicamente, comparten alteraciones en los sistemas de regulación emocional y control de impulsos:

**Estructura /
sistema**

Alteración principal

Amígdala	Hiperreactividad emocional (TLP, TEP).
Corteza prefrontal	Déficit de control de impulsos (TLP, TAP).
Serotonina	Disminución → impulsividad y agresividad.
Dopamina	Disregulación → búsqueda de sensaciones y recompensa.

2.2. Factores psicosociales

- **TLP:** trauma infantil, abuso, negligencia, apego inseguro.
- **TAP:** ambiente familiar hostil, abuso de sustancias, violencia temprana.
- **TEP:** crianza sobreprotectora o crítica, experiencias tempranas de rechazo.

□ En conjunto, estos factores generan **patrones rígidos de afrontamiento** ante el estrés emocional.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Trastorno Límite de la Personalidad (TLP)

Características principales (DSM-5)

1. Relaciones interpersonales intensas e inestables.
2. Imagen de sí mismo cambiante y frágil.
3. Impulsividad en ≥ 2 áreas: gasto, sexualidad, sustancias, conducción.
4. Conductas o amenazas suicidas / autolesiones.

5. Inestabilidad afectiva (emociones intensas y de corta duración).
6. Sensación crónica de vacío.
7. Esfuerzos frenéticos por evitar el abandono (real o imaginado).
8. Ira inapropiada o dificultad para controlarla.
9. Episodios de descontrol o disociación transitoria.

Epidemiología

- Prevalencia: 1–2% población general.
- 75% son mujeres.
- 10% riesgo de suicidio consumado.

Diagnóstico diferencial

Trastorno	Diferencia clave
Trastorno bipolar	Afectividad episódica, no reactiva.
T. histriónico	Búsqueda de atención sin autolesiones.
T. antisocial	Impulsividad sin remordimiento ni vacío afectivo.
☐ El TLP se caracteriza por intensidad emocional, impulsividad y miedo al abandono , con reacciones desproporcionadas ante el estrés interpersonal.	

3.2. Trastorno Antisocial de la Personalidad (TAP)

Características principales (DSM-5)

1. Desprecio por las normas sociales.
2. Conductas repetidas que violan derechos de los demás.

3. Mentira o manipulación habitual.
4. Impulsividad e irresponsabilidad.
5. Agresividad o irritabilidad frecuentes.
6. Falta de remordimiento o culpa.
7. Antecedentes de **trastorno disocial antes de los 15 años**.

Epidemiología

- Prevalencia: 1–4% población general (10× más en hombres).
- Alta comorbilidad con **consumo de sustancias y conductas delictivas**.

Diagnóstico diferencial

Trastorno	Diferencia clave
TLP	Emocionalidad intensa y culpa posterior.
Psicopatía (Cleckley/Hare)	TAP con mayor frialdad, cálculo y encanto superficial.
Trastornos adictivos	Conductas motivadas por la sustancia, no por desprecio moral.
☐ Los pacientes antisociales rara vez buscan tratamiento voluntariamente ; suelen ser derivados por orden judicial o por presión social.	

3.3. Trastorno Evitativo de la Personalidad (TEP)

Características principales (DSM-5)

1. Inhibición social marcada.
2. Hipersensibilidad a la crítica o rechazo.
3. Evita actividades con contacto interpersonal significativo.

4. Desea relaciones afectivas, pero teme la humillación.
5. Se percibe como socialmente inepto o inferior.
6. Miedo constante al rechazo.
7. Restricción de actividades nuevas por temor a fallar.

Epidemiología

- Prevalencia: 2–3%.
- Igual frecuencia en hombres y mujeres.
- Inicio en adolescencia, curso crónico pero con buena respuesta terapéutica.

Diagnóstico diferencial

Trastorno	Diferencia clave
Fobia social	Focalizada en situaciones concretas.
Trastorno de ansiedad generalizada	Preocupación excesiva sin evitación social.
Trastorno dependiente	Necesidad de apoyo sin miedo al rechazo.

☐ El TEP es el único de los tres donde **el deseo de vínculo es alto, pero el miedo al rechazo paraliza.**

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico es **clínico**, basado en **entrevista psiquiátrica estructurada** y **historia evolutiva**.

Se utilizan instrumentos como:

- **SCID-II (Structured Clinical Interview for DSM-II).**

- **Inventario de Millon (MCMI-III).**
- **Evaluación funcional psicosocial (GAF).**

No existen exámenes de laboratorio específicos.

Pueden solicitarse estudios complementarios solo para descartar causas médicas o comorbilidades (p. ej., consumo de sustancias, depresión).

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1. Principios generales

- En Chile, los TP se abordan principalmente a través de la **red de Salud Mental (COSAM, Hospital de Día, programas SENDA)**.
 - El tratamiento es **psicoterapéutico**; la farmacoterapia es **coadyuvante**.
 - En APS, el enfoque se centra en la **detección, contención y derivación**.
-

5.2. Trastorno Límite

- **Terapia dialéctico-conductual (TDC):** terapia de elección (Linehan).
 - Regula emociones.
 - Reduce autolesiones.
 - Mejora relaciones interpersonales.
- **Terapia de esquemas:** útil para modificar creencias disfuncionales (“soy malo”, “seré abandonado”).
- **Fármacos (coadyuvantes):**
 - ISRS: depresión, ansiedad.
 - Estabilizadores (lamotrigina, valproato): impulsividad.
 - Antipsicóticos atípicos (quetiapina): irritabilidad y disociación.

- ☐ Evitar benzodiacepinas por riesgo de abuso o desinhibición.
-

5.3. Trastorno Antisocial

- **Objetivo principal:** control de impulsividad y reducción de conductas violentas.
- **Psicoterapia cognitivo-conductual (TCC):** foco en responsabilidad personal y consecuencias.
- **Programas de reinserción social y laboral (SENDA, justicia penal juvenil).**
- **Fármacos (solo en casos seleccionados):**
 - ISRS: irritabilidad, agresividad.
 - Antipsicóticos o estabilizadores: control de impulsividad.

- ☐ La motivación terapéutica suele ser baja; se requiere trabajo intersectorial (salud, justicia, educación).
-

5.4. Trastorno Evitativo

- **Terapia cognitivo-conductual:** exposición progresiva a situaciones sociales, reestructuración cognitiva y entrenamiento en habilidades sociales.
- **Psicoterapia de apoyo:** refuerzo de autoestima y autoconfianza.
- **Farmacoterapia:** ISRS o ansiolíticos de corta duración si existe ansiedad comórbida.

- ☐ El pronóstico del TEP es **muy favorable** con intervención temprana y apoyo terapéutico sostenido.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Trastorno	Complicaciones principales	Pronóstico
o		

Límite	Intentos suicidas, autolesiones, abuso de sustancias.	Mejoría significativa con terapia intensiva (>50% remisión a 10 años).
Antisocial	Conductas delictivas, violencia, dependencia, desempleo.	Desfavorable; tiende a mejorar parcialmente con la edad.
Evitativo	Aislamiento social, depresión secundaria, baja autoestima.	Favorable con psicoterapia estructurada.

☐ En todos los casos, la **adhesión terapéutica y red de apoyo familiar** son determinantes del pronóstico.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐

Perlas clínicas

1. El **trastorno límite** es el de **mayor riesgo suicida** entre todos los TP.
2. La **TDC** es la terapia de elección en TLP.
3. El **trastorno antisocial** requiere haber tenido **trastorno disocial antes de los 15 años**.
4. El **trastorno evitativo** combina **deseo de afecto** con **miedo intenso al rechazo**.
5. El **TLP es egosintónico** (el paciente no ve su conducta como problema).
6. En APS, el rol es **detectar y derivar**, evitando etiquetar prematuramente.
7. Los **fármacos no corrigen la personalidad**, solo alivian síntomas comórbidos.

☐

Errores comunes

- Confundir TLP con trastorno bipolar.
 - Intentar manejar TP graves solo con medicamentos.
 - No considerar el antecedente de trastorno disocial en el TAP.
 - No diferenciar TEP de fobia social.
 - Interpretar conductas del TLP como “manipulativas” sin comprender su origen emocional.
 - Usar benzodiacepinas en TLP (riesgo alto de dependencia).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Trastorno Límite:** impulsividad, inestabilidad emocional y riesgo suicida; tratamiento con **terapia dialéctico-conductual**.
2. **Trastorno Antisocial:** desprecio por normas, manipulación y ausencia de culpa; requiere **TCC y reinserción social**.
3. **Trastorno Evitativo:** miedo al rechazo con deseo de afecto; responde bien a **TCC y psicoterapia de apoyo**.
4. El diagnóstico es **clínico y evolutivo**, basado en patrones persistentes.
5. La **farmacoterapia es coadyuvante** y dirigida a síntomas asociados.
6. En APS, el manejo principal es **detección temprana, contención y derivación**.
7. El **pronóstico mejora con adherencia terapéutica** y red de apoyo sólida.